

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE PERFECCIONISMO DE FROST (FMPS)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación del Perfeccionismo Clínico, Preocupación por Errores y Crítica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala Multidimensional de Perfeccionismo de Frost (FMPS - 35 ítems).
Nombre Original (Inglés)	<i>Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS)</i>
Autores Originales	Drs. Randy O. Frost, Patricia Marten, Cathleen Lahart y R. Rosenblate (1990), Smith College.
Adaptaciones Españolas	Carrasco et al. (2010); Gelabert et al. (2011), Universidad Autónoma de Barcelona.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Cognitivo del Perfeccionismo Clínico (Frost).
Tipo de Instrumento	Autoinforme multidimensional de 35 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 13 años). Trastornos alimentarios (TCA), TOC, depresión y ansiedad.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos en autoadministración; 12 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico abierto de libre distribución para uso clínico e investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DEL PERFECCIONISMO CLÍNICO

La FMPS revolucionó la clinimetría al demostrar que el perfeccionismo no es un rasgo homogéneo de sana aspiración al logro, sino un constructo multifactorial en el que conviven componentes adaptativos (búsqueda de metas elevadas y organización) y componentes severamente patógenos: la **Preocupación por los Errores (CM)** y las **Dudas sobre las Acciones (DA)**, conocidos colectivamente como **Perfeccionismo Maladaptativo o Evaluativo**.

En el plano neurobiológico, las personas con alto perfeccionismo clínico presentan una hiperreactividad patológica del córtex cingulado anterior (ACC), evidenciada en estudios electrofisiológicos por un incremento desproporcionado en la amplitud del Potencial de Negatividad Relacionado con el Error (ERN, **Error-Related Negativity**). El cerebro del perfeccionista computa cualquier error leve como una amenaza existencial catastrófica que aniquila la autoestima, alimentando conductas de chequeo compulsivo, procrastinación paralizante y dietas restrictivas en TCA.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala FMPS	Ítems	Rango	Operacionalización Clínica y Fenomenológica
1. Preocupación por Errores (CM)	9, 14, 17, 18, 21, 23, 25, 32, 34 (9)	9 a 45	Tendencia a equiparar los errores con el fracaso total y la pérdida del respeto ajeno (núcleo patológico).
2. Dudas sobre Acciones (DA)	11, 13, 28, 33 (4)	4 a 20	Sensación crónica de que el trabajo realizado no está terminado o está imperfecto; necesidad de repasar.
3. Estándares Personales (PS)	4, 6, 12, 16, 19, 24, 30 (7)	7 a 35	Autoexigencia de metas desmesuradamente elevadas y excesiva importancia otorgada a su consecución.
4. Expectativas Parentales (PE)	1, 5, 15, 20, 26 (5)	5 a 25	Percepción de que los propios progenitores exigían una perfección implacable sin margen de fallo.
5. Crítica Parental (PC)	3, 7, 22, 35 (4)	4 a 20	Vivencia de haber sido castigado, avergonzado o juzgado duramente por los padres ante imperfecciones.
6. Organización (OR)	2, 8, 27, 29, 31, 35b (6)	6 a 30	Énfasis en el orden, pulcritud, método y organización espacial (dimensión funcional adaptativa).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en validaciones españolas (Gelabert et al., 2011; Carrasco et al., 2010): alfa de Cronbach de 0.88 a 0.91 para el total; CM (0.87), DA (0.75), PS (0.82), PE (0.84), PC (0.78) y OR (0.86).
Estructura Factorial	El AFC valida tanto el modelo de 6 factores de primer orden como la agrupación de segundo orden en dos macrodimensiones: Perfeccionismo Evaluativo Desadaptativo (CM, DA, PC, PE) y Perfeccionismo Positivo (PS, OR).
Validez Concurrente y Clínica	El componente maladaptativo (CM + DA) es un predictor independiente mayúsculo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (EAT-26, $r = 0.58$), sintomatología obsesiva (OCI-R, $r = 0.52$), ansiedad social y depresión.
Sensibilidad al Cambio	Sensible a intervenciones de TCC para perfeccionismo clínico (Fairburn; Egan et al., 2014), documentando caídas marcadas en Preocupación por Errores y Dudas.
Invarianza Clínica	Equivalencia de medida confirmada entre muestras clínicas con anorexia/bulimia nerviosa y población comunitaria.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los reactivos se responde de 1 a 5 (1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «Neutral», 4 = «De acuerdo», 5 = «Totalmente de acuerdo»). No contiene reactivos invertidos:

- **1. Puntuación por Subescalas:** Suma directa de los ítems de cada una de las 6 dimensiones.
- **2. Índice de Perfeccionismo Clínico Maladaptativo (CM + DA):** Suma de los reactivos de Preocupación por Errores más Dudas sobre Acciones (13 ítems, Rango: **13 a 65 puntos**). Es el indicador clinimétrico rector.
- **3. Puntuación Total FMPS (sin Organización):** Suma de CM + DA + PS + PE + PC (29 ítems, Rango: **29 a 145 puntos**). La escala de Organización (OR) se interpreta de forma independiente y nunca debe sumarse a la patología.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (ÍNDICE MALADAPTATIVO CM + DA)

Estratificación	Puntuación	Perfil de Autoexigencia	Conducta Asistencial Recomendada
Adaptativo Sano	13 a 28 puntos	Autoexigencia flexible y realista	Tolerancia adecuada al error. Los fallos se viven como experiencias de aprendizaje sin coste para la valía personal.
Moderado	29 a 39 puntos	Autoexigencia rígida intermitente	Vulnerabilidad a frustración y chequeos reiterativos ante exámenes o entregas laborales. Psicoeducación.
Clínico Severo	40 a 52 puntos	Perfeccionismo clínico (corte >= 40)	Fusión entre rendimiento y valor personal; terror al error; procrastinación severa. TCC de perfeccionismo.
Extremo	53 a 65 puntos	Tiranía autocrítica destructiva	Parálisis conductual completa, conductas de purga/restricción en TCA, o rituales obsesivos graves e invalidantes.

ALERTA DIAGNÓSTICA: PERFECCIONISMO CLÍNICO >= 40 PUNTOS:

Un puntaje en **CM + DA >= 40 puntos** actúa como un factor de mantenimiento transdiagnóstico de primer orden. En Anorexia Nerviosa y Bulimia (EAT-26), este rasgo perpetúa las reglas dietéticas implacables; en TOC (OCI-R), dispara la necesidad compulsiva de simetría y verificación; y en depresión, bloquea el inicio de cualquier actividad por miedo a no hacerla de forma impecable.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN PERFECCIONISMO CLÍNICO

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN TCC TRANSDIAGNÓSTICO (EGAN, WADE & SHAFRAN):

- **Paso 1: Desmantelar la Identificación Rendimiento-Valor:** Romper la creencia de que «valgo según lo que rindo». Introducir autocompasión y ampliar los dominios de autoevaluación (amistad, disfrute, descanso).
- **Paso 2: Experimentos Conductuales de Imperfección Deliberada:** Prescribir tareas donde el paciente cometa errores menores intencionadamente (ej. enviar correos con una errata tipográfica menor, dejar una cama sin hacer, llegar 3 minutos tarde). Comprobar que no ocurre la catástrofe social temida.
- **Paso 3: Reducción de Chequeos y Dudas:** Limitar el número de revisiones a un máximo de 1 vez antes de entregar cualquier trabajo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ANOREXIA NERVIOSA Y PERFECCIONISMO

Paciente: Mujer de 22 años, estudiante de medicina con matrícula de honor, acude a consulta especializada por Anorexia Nerviosa restrictiva (IMC 16.8) y crisis de angustia antes de exámenes. Refiere que si saca un 9 en una prueba siente que es «una incompetente total».

Resultados Iniciales en la FMPS:

- **Preocupación por los Errores (CM): 42 / 45 puntos** (Extremo; ítem 9 = 5, ítem 14 = 5: pánico total al fallo).
- **Dudas sobre las Acciones (DA): 18 / 20 puntos** (revisa sus apuntes y trabajos hasta 8 veces).
- **Índice Maladaptativo (CM + DA): 60 / 65 puntos** (Percentil 99 clínico).
- **Estándares Personales: 34 / 35; Expectativas Parentales = 22 / 25.**

Formulación Clínica: El perfeccionismo clínico constituye el motor central del trastorno alimentario. La restricción dietética es el área donde la paciente traslada su exigencia de control impecable; cualquier desviación calórica es vivida con el mismo horror que suspender una asignatura.

Tratamiento TCC y Evolución: Protocolo de 16 sesiones enfocado en flexibilización de reglas rígidas y tolerancia al error. Al finalizar: CM + DA descendió a **31 puntos**, normalizándose el IMC a 19.5 y reduciéndose el tiempo de estudio a límites compatibles con el ocio.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DIFERENCIAL

ALERTA CRÍTICA: PERFECCIONISMO Y RIESGO SUICIDA

En la literatura suicidológica, la Preocupación por los Errores (CM ≥ 38) junto a Crítica Parental alta es un potente predictor de suicidio "sin previo aviso" ante fracasos académicos o rupturas afectivas (hipótesis de escape del self).

ERROR HABITUAL CON LA SUBESCALA ORGANIZACIÓN

Nunca debe incluirse la puntuación de Organización (OR) en el cómputo del perfeccionismo desadaptativo global. El gusto por el orden es una faceta constructiva que no correlaciona con psicopatología clínica.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. *Cognitive Therapy and Research*, 14(5), 449–472.
2. Gelabert, E., García-Esteve, L., Martín-Santos, R., Gutiérrez, F., Torres, A., & Subirà, S. (2011). Psychometric properties of the Frost Multidimensional Perfectionism Scale in a Spanish sample. *Psicothema*, 23(3), 459–465.
3. Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: a cognitive-behavioural analysis. *Behaviour Research and Therapy*, 40(7), 773–791.
4. Egan, S. J., Wade, T. D., Shafran, R., & Antony, M. M. (2014). *Cognitive-behavioral treatment of perfectionism*. Guilford Publications.